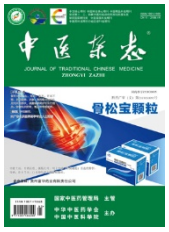

中医杂志
Journal of Traditional Chinese Medicine
ISSN 1001-1668,CN 11-2166/R

《中医杂志》网络首发论文

题目：　通腑法治疗中风病临床应用专家共识
作者：　刘向哲，王新志，赵敏，高颖，蔡业峰
收稿日期：　2024-07-29
网络首发日期：　2025-04-30
引用格式：　刘向哲，王新志，赵敏，高颖，蔡业峰．通腑法治疗中风病临床应用专家共识[J/OL]．中医杂志. https://link.cnki.net/urlid/11.2166.R.20250429.1409.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-04-30 11:30:54　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.2166.R.20250429.1409.002

通腑法治疗中风病临床应用专家共识

中华中医药学会通腑法治疗中风病临床应用专家共识项目组

［摘要］ 合理使用通腑法对于中风病的治疗具有重要意义。基于此，遵照中华中医药学会有关指南和共识制订技术方案，组织全国相关领域专家制订《通腑法治疗中风病临床应用专家共识》，形成了与通腑法相关的共识建议和通腑法治疗中风病的推荐意见，旨在进一步规范通腑法的临床应用，促进通腑法临床应用水平的提高，从而更好地指导临床诊疗工作。

［关键词］ 中风病；通腑法；专家共识；共识建议；推荐意见

通腑法源于下法，其理论基础可追溯至《黄帝内经》。东汉张仲景将通腑法理论与临床相结合，创造“承气汤”系列通腑方。中风病急性期病机属本虚标实，本虚以气血衰少为主，标实以痰浊瘀血为主。痰瘀互阻，气机升降失常，郁而化热，痰热瘀血壅滞中焦，多导致腑气不通，症见腹胀腹痛、便秘等，是中风病急性期的常见症状[1]。通腑法是治疗中风病腑气不通的主要方法之一，具有“上病下治”的特点。随着中西医结合研究的不断发展，以王永炎院士为代表的诸多现代医家进一步拓展通腑法在中风病临床中的应用，形成了理法方药相对完整、系统的理论体系[2-3]。研究表明，通腑法能够有效减轻中风病患者的神经功能损伤、防止病情恶化及改善预后[4-5]。因此，合理使用通腑法对于中风病的治疗具有重要意义。

目前关于通腑法的定义、适应证、禁忌证、使用方法及作用效果等问题仍缺乏相应的临床共识。基于此，《通腑法治疗中风病临床应用专家共识》（简称本共识）项目组遵照中华中医药学会有关指南和共识制订的技术方案，组织全国相关领域专家制订本共识，形成了与通腑法相关的共识建议和通腑法治疗中风病的推荐意见，旨在进一步规范通腑法的临床应用，促进通腑法临床应用水平的提高，从而更好地指导临床诊疗工作。本共识经中华中医药学会立项，并于2024年7月3日发布（编号：GS/CACM 346-2024），同时在国际实践指南注册平台（http：//www. guidelines-registry. org）注册（注册号：IPGRP-2020CN151）。本共识制订的具体流程和方法见附件（请扫描本文二维码获取）。本共识将在临床推广应用中不断完善并定期修订。

基金项目：中华中医药学会团体标准项目（20211213-GS-CACM）；河南省中医药科研专项课题（2023ZXZX1077）；河南省中医药学科领军人才项目（豫卫中医函〔2021〕8号）

1　范围

本共识适用于各级中医院、中西医结合医院、综合医院以及基层卫生服务机构的临床医师参考使用，应用对象为符合通腑法应用指征的中风病患者。

2　定义

通腑法是指运用具有泄下作用的药物或非药物疗法，以治疗毒邪内攻、肠道瘀滞等所致腑气不通病证为目的的一类治法。（共识建议）

3　适应证

临床中通腑法多用于痰热腑实证、阳明腑实证、大肠实证、热结里实证、胆腑郁热证、痰热壅肺证、腑实阴伤证、风邪中腑证、瘀热（毒）互结证。（共识建议）

4　适用疾病

本共识主要针对缺血性脑卒中、出血性脑卒中，通腑法亦适用于胰腺炎、脓毒症、不完全性肠梗阻、各型肺炎、慢性阻塞性肺疾病、各种腹部手术术后、慢性肾衰竭。（共识建议）

5　应用原则与时机

5.1　有是证用是方

通腑法一般情况下用于出现上述疾病、证候的

患者，即有是证用是方。（共识建议）

5.2　超适应证酌情应用

中风病急性期，无腑实之势，或中风病超急性期排除再发风险后；另外，急性胰腺炎发病48小时内、不完全性肠梗阻及胃肠术后肠粘连禁食/水患者需酌情应用。（共识建议）

5.3　早期应用

脑出血急性期应用以预防脑水肿；腹部手术后亦可早期应用，以预防肠粘连；卒中相关性肺炎风险评估评分（assessment of acute stroke-related pneumonia score，A2DS2）高危者应用以预防卒中相关性肺炎。（共识建议）

6　疗程

通腑法使用疗程，以症状为度，不拘泥于具体时间。具体症状参考：通腑后，腑气通畅即停；或腑通后继续用药以防止反复，如保持大便略稀，维持每日1或2次；或腑通后继续用药至舌质、舌苔、脉象改变，即黄苔或黄腻苔渐去，代之以薄白苔而舌质由暗红转暗淡；弦滑脉渐去。（共识建议）

7　常用辨证治法

临床疾病情况复杂，通腑法多配伍他法使用，常见辨证治法有通腑泄热、通腑化痰、化瘀通腑、通腑开窍、行气通腑、通腑解毒、益气通腑、温阳通腑、滋阴通腑、养血通腑。（共识建议）

8　常用治疗方式

临床治疗方式包括中药（含中成药）口服、鼻饲、灌肠、直肠滴注及针灸、推拿按摩、穴位贴敷。（共识建议）

9　常用方药

经典名方：承气汤类方（大承气汤、小承气汤、调胃承气汤、增液承气汤、桃核承气汤、宣白承气汤、白虎承气汤）、增液汤、抵当汤或抵当丸、大柴胡汤、厚朴三物汤、大黄牡丹汤、大黄附子汤、麻子仁丸、大成汤、大陷胸汤、凉膈散、大黄黄连泻心汤、新加黄龙汤、温脾汤、济川煎。（共识建议）

中成药：清胰利胆颗粒、麻仁润肠丸、芪蓉润肠口服液、通便灵胶囊。（共识建议）

经验方：星蒌承气汤、中风星蒌通腑胶囊、涤热醒神汤、通腑醒神汤、通腑醒神胶囊、通腑合剂、宣肺通腑汤、排石汤、通腑净化汤、肝豆汤。（共识建议）

常用中药：大黄、厚朴、枳实、芒硝、桃仁、瓜蒌、木香、当归、槟榔、莱菔子。（共识建议）

10　针灸常用穴位

足三里、天枢、上巨虚、中脘、合谷。（共识建议）

11　联合用药

使用常见平喘类、解热镇痛类、糖皮质激素类、调节水电解质平衡类、溶栓类、脱水类、镇静类、抗血小板聚集类、消化道和心脑血管造影剂、利尿剂、促凝血类药物时，加用通腑法治疗暂未发现明显不良反应，使用时无特殊禁忌。（共识建议）

12　安全性

12.1　不良反应

通腑法误用或使用太过可能会导致某些不良反应，如腹泻、腹痛、肛门下坠感、恶心、呕吐、食欲下降等，停止使用通腑法或给予对症治疗后多可好转。（共识建议）

12.2　特殊人群用药

1）慎用人群：素体虚弱、大便偏稀的老年患者；月经期或功能性子宫出血患者；婴幼儿患者；哺乳期妇女；消化道活动性出血、溃疡性结肠炎、肛瘘患者。（共识建议）

2）禁用人群：脱证患者；妊娠期妇女；对相关中药过敏的患者。（共识建议）

13　作用机制

通腑法可能通过减轻炎症反应、减轻脑水肿、调节脑肠轴、保护神经细胞、改善脑循环、减轻氧化应激、促进神经元及血管修复与再生、改善凝血功能机制发挥治疗神经系统疾病的作用[5]。（共识建议）

通腑法可能通过改善肠道功能屏障、调节肠道微生态、减轻炎症反应、降低腹内压、调节胃肠激素分泌、改善血流动力学和血液流变学、提高免疫功能、调节氧化应激状态发挥治疗胃肠道系统疾病的作用[6]。（共识建议）

通腑法可能通过减轻炎症反应、控制感染、调节肠道菌群、改善通气功能、减少气管分泌物、提高免疫力、改善血液流变学发挥治疗呼吸系统疾病的作用[7]。（共识建议）

14 临床问题与推荐意见

14.1 临床问题1：对于缺血性中风急性期患者，在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能否更好地缓解病情、改善预后？

推荐意见：1）对于缺血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能提高临床有效率及日常生活能力，能促进神经功能恢复和改善预后，并且降低死亡率（D级证据，弱推荐）；2）对于缺血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能提高临床有效率（B级证据，强推荐）；3）对于缺血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低死亡率（B级证据，强推荐）；4）对于缺血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评分，促进神经功能恢复（C级证据，强推荐）；5）对于缺血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能提高Barthel指数（BI指数），改善患者日常生活能力（C级证据，强推荐）；6）对于缺血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低改良Rankin量表（mRS）评分，改善预后（D级证据，弱推荐）。

证据概要：Meta分析［19项随机对照试验（RCT）[8-26]，纳入患者2294例］显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著提高临床有效率［RR=1.22，95%CI（1.18，1.27），P<0.001］。Meta分析（7项RCT[25-31]，纳入患者1383例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低死亡率［RR=0.34，95%CI（0.21，0.54），P<0.001］。Meta分析（22项RCT[9, 29, 32-51]，纳入患者2273例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低NIHSS评分［MD=-2.65，95%CI（-3.45，-1.86），P<0.001］。Meta分析（14项RCT[13, 16, 27, 32, 36-37, 39-40, 42, 44, 48, 50, 52-53]，纳入患者1374例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著提高BI指数［MD=12.88，95%CI（9.88，15.88），P<0.001］。Meta分析（2项RCT[35, 48]，纳入患者147例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低mRS评分［MD=-0.46，95%CI（-0.56，-0.35），P<0.001］。

14.2 临床问题2：对于出血性中风急性期患者，在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能否更好地缓解病情、改善预后？

推荐意见：1）对于出血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能提高临床有效率及促进神经功能恢复，提高患者意识水平和日常生活能力，并且降低死亡率（C级证据，强推荐）；2）对于出血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能提高临床有效率（B级证据，强推荐）；3）对于出血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低死亡率（C级证据，弱推荐）；4）对于出血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低NIHSS评分，促进神经功能恢复（C级证据，强推荐）；5）对于出血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能升高格拉斯哥昏迷评分（GCS），改善患者意识水平（C级证据，强推荐）；6）对于出血性中风急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能升高BI指数，改善患者日常生活能力（C级证据，弱推荐）。

证据概要：Meta分析（16项RCT[54-69]，纳入患者1496例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著提高临床有效率［RR=1.25，95%CI（1.18，1.31），P<0.001］。Meta分析（14项RCT[58-59, 61, 65-66, 70-78]，纳入患者1358例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低死亡率［RR=0.53，95%CI（0.39，0.74），P<0.001］。Meta分析（12项RCT[58, 79-89]，纳入患者911例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低NIHSS评分［MD=-4.19，95%CI（-5.35，-3.03），P<0.001］。Meta分析（8项RCT[56, 59, 72, 80, 82, 90-92]，纳入患者657例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著升高GCS评分［MD=1.54，95%CI（0.78，2.29），P<0.001］。Meta分析（8项RCT[54, 79, 82-83, 85, 87, 91, 93]，纳入患者636例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著升高BI指数［MD=12.03，95%CI（8.66，15.41），P<0.001］。

14.3 临床问题3：对于中风病急性期患者，在西医常规治疗基础上加用通腑法，能否降低卒中相关性肺炎发生率、减轻炎症反应？

推荐意见：1）对于中风病急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低卒中相关性肺炎发生率，减轻卒中相关性肺炎炎症反应（D级证据，强推荐）；2）对于中风病急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低卒中相关性肺炎发生率（C级证据，强推

荐）；3）对于中风病急性期卒中相关性肺炎患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能减轻卒中相关性肺炎炎症反应（D级证据，强推荐）。

证据概要：Meta分析（11项RCT[9, 19, 28, 56, 59, 78, 93-97]，纳入患者1072例）显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低卒中相关性肺炎发生率［*RR*=0.50，95%*CI*（0.42，0.60），*P*<0.001］；Meta分析显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗可显著降低超敏C反应蛋白［3项RCT[94, 96-97]，纳入患者251例，*MD*=-1.25，95%*CI*（-1.42，-1.08），*P*<0.001］和白细胞计数［2项RCT[94, 98]，纳入患者132例，*MD*=-1.06，95%*CI*（-1.34，-0.78），*P*<0.001］。

14.4　临床问题4：对于中风病急性期患者，在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能否降低应激性溃疡和消化道出血发生率，进而改善胃肠功能？

推荐意见：对于中风病急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低应激性溃疡和消化道出血发生率，改善胃肠功能（D级证据，弱推荐）。

证据概要：Meta分析显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗，可显著降低应激性溃疡发生率［4项RCT[28, 56, 59, 93]，纳入患者336例，*RR*=0.57，95%*CI*（0.38，0.84），*P*<0.001］和消化道出血发生率［2项RCT[19, 78]，纳入患者285例，*RR*=0.67，95%*CI*（0.46，0.96），*P*<0.05］。

14.5　临床问题5：对于中风病急性期患者，在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能否降低肾损伤、高热、心脏损伤发生率？

推荐意见：对于中风病急性期患者，推荐在西医常规治疗基础上加用通腑法治疗，能降低肾损伤、高热、心脏损伤发生率（D级证据，弱推荐）。

证据概要：Meta分析显示，通腑法联合常规治疗相比单纯常规治疗，可显著降低肾损伤发生率［2项RCT[28, 99]，纳入患者106例，*RR*=0.13，95%*CI*（0.04，0.41），*P*<0.001］、高热发生率［2项RCT[28, 59]，纳入患者126例，*RR*=0.60，95%*CI*（0.37，0.98），*P*<0.05］和心脏损伤发生率［3项RCT[9, 28, 93]，纳入患者298例，*RR*=0.33，95%*CI*（0.18，0.62），*P*<0.001］。

利益冲突声明

本共识制订过程中无企业人员参与，项目组成员在项目正式启动前均签署了“利益冲突声明书”并存档，共识制订过程中无利益冲突。

共识制订工作组

专家组（按姓名笔画排序）

起草专家：丁砚兵（湖北省中医院）、王保亮（河南中医药大学第一附属医院）、王菁婧（郑州大学第一附属医院）、王新志（河南中医药大学第一附属医院）、吕国雄（江西中医药大学附属医院）、伍大华（湖南省中医药研究院附属医院）、刘向哲（河南中医药大学第一附属医院）、闫咏梅（陕西中医药大学附属医院）、关东升（河南省中医院）、李小黎（北京中医药大学第三附属医院）、李乐军（苏州市中医医院）、余学庆（河南中医药大学第一附属医院）、况时祥（贵州中医药大学第二附属医院）、张允岭（中国中医科学院西苑医院）、张怀亮（河南中医药大学第一附属医院）、邵明义（河南中医药大学第一附属医院）、招远祺（广东省中医院）、林亚明（云南中医药大学第一附属医院）、林安基（厦门市中医院）、周晓卿（北京中医药大学深圳医院）、赵敏（河南中医药大学第一附属医院）、赵德喜（长春中医药大学附属医院）、荆志伟（中国中医科学院）、胡跃强（广西中医药大学第一附属医院）、徐向青（山东中医药大学附属医院）、高颖（北京中医药大学东直门医院）、郭增元（内蒙古自治区中医院）、蔡业峰（广东省中医院）

参与讨论及征求意见专家：王丹（河南中医药大学第一附属医院）、王成银（广州市中医医院）、王艳（浙江省中医院）、王晓玲（陕西省安康市中医医院）、王健（长春中医药大学附属医院）、王鹏琴（辽宁中医药大学附属医院）、支英杰（中国中医科学院中医临床基础医学研究所）、卢云（成都中医药大学附属医院）、卢明（广东省中医院）、田军彪（河北省中医院）、兰瑞（河南中医药大学第一附属医院）、达瓦次仁（西藏自治区藏医院）、乔利军（广东省中医院）、全亚萍（深圳市罗湖区中医院）、刘绪银（湖南中医药大学附属正大邵阳骨伤科医院）、安红伟（柳州市中医医院）、孙江燕（河南中医药大学第一附属医院）、李合国（河南中医药大学第一附属医院）、李军（海南博鳌一龄生命养护中心）、杨东东（成都中医药大学附属医院）、杨国防（河南中医药大学第一附属医院）、杨俊红（河南中医药大学第一附属医院）、杨海燕（河南中医药大学第一附属医院）、吴明华（江苏省中医院）、余尚贞（江门中医院）、邹忆怀（北京中

医药大学东直门医院）、邹伟（黑龙江中医药大学附属第一医院）、汪瀚（安徽中医药大学第一附属医院）、沈晓明（河南中医药大学第一附属医院）、张杰（河南中医药大学第一附属医院）、张道培（河南中医药大学第一附属医院）、张楠（河南中医药大学第一附属医院）、张燕平（河南中医药大学第一附属医院）、陈志刚（北京中医药大学东方医院）、陈岚榕（福建中医药大学附属康复医院）、陈亮（陕西省安康市中医医院）、陈朝俊（广州中医药大学附属广州中西医结合医院）、武继涛（河南中医药大学第一附属医院）、金杰（河南中医药大学第一附属医院）、金泽（黑龙江中医药大学附属第二医院）、周震（天津中医药大学第二附属医院）、周霞（山东中医药大学第二附属医院）、郑国庆（浙江省中医院）、赵杨（南京市中医院）、胡晓灵（新疆维吾尔自治区中医医院）、俞晓飞（上海中医药大学附属龙华医院）、姚欣艳（湖南中医药大学第一附属医院）、徐进（河南中医药大学第一附属医院）、高志卿（河南中医药大学第一附属医院）、高敏（广东省第二中医院）、海英（辽宁中医药大学附属医院）、曹克刚（北京中医药大学东直门医院）、韩辉（安徽中医药大学第一附属医院）、谢颖桢（北京中医药大学东直门医院）、裘涛（浙江省中医院）、雷励（重庆市北碚区中医院）、路永坤（河南中医药大学第一附属医院）、黎明全（长春中医药大学附属第三临床医院）

方法学专家：刘建平（北京中医药大学循证医学中心）、苏祥飞（中华中医药学会）

药学专家：唐进法（河南中医药大学第一附属医院）

工作组秘书：马驰远（河南中医药大学第一附属医院）、孙永康（河南中医药大学第一附属医院）、赵文举（河南中医药大学第一附属医院）、贺晨菲（河南中医药大学第一附属医院）

牵头单位：河南中医药大学第一附属医院

牵头专家：刘向哲（河南中医药大学第一附属医院）

执笔人：刘向哲✉（河南中医药大学第一附属医院）、王新志（河南中医药大学第一附属医院）、赵敏（河南中医药大学第一附属医院）、高颖（北京中医药大学东直门医院）、蔡业峰（广东省中医院）

✉ 通讯作者：liuxiangzhe@163.com

参考文献

[1]徐丹，张兰坤，过伟峰，等．“瘀热”病机对脑出血急性期病情及预后的影响[J]．中医杂志，2011，52(22)：1922-1924，1938.

[2]王永炎，谢颖桢．化痰通腑法治疗中风病痰热腑实证的源流及发展(一)：历史源流、证候病机及临床应用[J]．北京中医药大学学报(中医临床版)，2013，20(1)：1-6，24.

[3]王莹莹，杨金生．通腑法治疗中风病的源流、机制和现代应用研究概况[J]．中医杂志，2009，50(9)：847-849.

[4]崔洪玉，赵德喜，王若男，等．中医治疗脑出血的研究进展[J]．中华中医药学刊，2020，38(2)：81-83.

[5]李建香，丁德经，张兰坤，等．凉血通瘀方对脑出血实证患者血清神经营养因子和氧化应激的影响[J]．中医杂志，2020，61(15)：1330-1333.

[6]刘媛，唐洪梅，钟如帆，等．健脾通腑颗粒对肝郁脾虚型便秘型肠易激综合征大鼠模型的作用及机制研究[J]．中华中医药学刊，2018，36(12)：2870-2874.

[7]裴爽，李华，裴丽红，等．益气通腑法中药灌肠辅助治疗慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭[J]．长春中医药大学学报，2024，40(6)：650-654.

[8]张元明，邹忆怀，耿昌，等．化痰通腑法对急性脑梗死病人Hcy水平及神经功能缺损程度评分的影响[J]．中西医结合心脑血管病杂志，2017，15(6)：654-656.

[9]孟祥杰．自拟开窍通腑汤对急性脑梗死患者血管内皮功能的影响[J]．中国中医急症，2017，26(2)：366-368.

[10]晁卫红，黄碧涛，杨建红．清热通腑开窍法治疗急性脑梗塞(痰热腑实证)疗效观察[J]．辽宁中医杂志，2014，41(4)：689-690.

[11]赵洁．缺血性中风急性期应用通腑泻热化痰法疗效观察[J]．山东中医杂志，2014，33(7)：548-549.

[12]陈立，李兰，韩悦，等．化瘀通腑开窍法对急性脑梗死患者血管内皮功能的影响及疗效观察[J]．中国中医急症，2013，22(12)：2027-2028.

[13]张春良，刘宏顺．大黄通腑汤治疗痰热腑实证急性脑梗死神经系统损害80例临床观察[J]．中医杂志，2012，53(6)：499-502.

[14]付渊博，邹忆怀，王新志．星蒌通腑汤治疗急性缺血性中风痰热腑实证临床观察[J]．中华中医药学刊，2010，28(3)：668-670.

[15]付玉．自拟化痰祛瘀通腑汤治疗急性脑梗死临床研究[J]．辽宁中医杂志，2010，37(6)：1053-1054.

[16]牟方波，郭鹏，卢正海．祛痰通腑颗粒治疗以痰瘀腑实型为主急性脑梗死的临床研究[J]．中西医结合心脑血管病杂志，2009，7(10)：1161-1162.

[17]杨宏勇，冀彦丽，王淑芳，等．中风Ⅰ号方治疗急性

重型脑梗死30例疗效观察[J]. 中国中医药信息杂志，2008,15(8):66.
[18]肖蕾，赵建国，王立新，等. 针药结合解毒通腑法对脑梗死急性期痰热腑实证病人神经功能的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2007,5(12):1168-1169.
[19]何银辉，罗仕德，杨晖. 通腑泻浊法对急性脑梗死促醒作用的疗效观察[J]. 中国中医急症，2006,15(4):339-340.
[20]王桥专. 中西医综合疗法治疗急性缺血性中风60例临床观察[J]. 江苏中医药，2006,27(11):28-29.
[21]孙纪峰. 活血通腑方治疗脑梗死66例疗效观察[J]. 中国中医急症，2005,14(10):929-930.
[22]王进，王保申. 通腑法治疗急性脑梗死90例临床观察[J]. 四川中医，2005,23(4):45-46.
[23]丁萍，谌剑飞，罗玉韵. 通腑泻浊法治疗急性脑梗死及其对垂体-肾上腺激素水平的影响[J]. 中国中医急症，2005,14(2):106-107.
[24]杨劲松，罗治华，钟妙文，等. 益气活血化瘀通腑中药配合降纤酶治疗急性脑梗死的临床研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2005,3(8):666-667.
[25]张树芳，隋晓杰，李振江，等. 益气祛瘀化痰通腑法治疗急性脑梗死临床观察[J]. 中国中医急症，2005,14(8):721-722,704.
[26]王新志，李燕梅，刘向哲，等. 中风星蒌通腑胶囊治疗急性缺血性中风120例[J]. 中医药学刊，2002,20(2):153-154.
[27]姚梓平，何春辉，段丽君，等. 化痰通腑类汤药对缺血性中风病人炎症因子的影响及其神经保护作用机制研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2017,15(13):1559-1562.
[28]何剑炜，白慧梅，宋怡. 通腑泻浊法配合针刺治疗重症后循环脑梗死临床观察[J]. 四川中医，2012,30(7):132-134.
[29]潘东，陈可为，白慧梅. 通腑泻浊法灌肠防治急性脑梗塞后甘露醇肾损害临床疗效研究[J]. 时珍国医国药，2012,23(12):3072-3074.
[30]李燕梅，王新志，刘向哲，等. 通腑化痰法配合西医疗法治疗急性缺血性中风160例临床观察[J]. 中医杂志，2002,43(11):831-832.
[31]凌方明，陈景亮，龙允杰. 祛痰化瘀通腑法治疗急性脑梗塞疗效观察[J]. 中国中医急症，2001,10(6):321-322.
[32]宋聪琳，杨金山. 化痰通腑汤加减治疗缺血性中风患者临床疗效和对血清标志物的影响[J]. 辽宁中医杂志，2022,49(6):80-83.
[33]张敬华，惠振，王苏雷，等. 枳实大黄汤加减联合通脑活络针刺法治疗脑梗死急性期的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2022,20(7):1304-1307.
[34]彭焱，邓红卫，许杰，等. 自拟通腑开窍方治疗脑梗死恢复期患者疗效观察及对神经功能评分、颈部血流动力学的影响[J]. 辽宁中医杂志，2022,49(8):117-119.
[35]仇珺，林生君，王胜芳，等. 通腑通络开窍汤治疗急性脑梗死疗效及对患者髓鞘碱性蛋白、可溶性细胞间黏附分子-1和神经元特异性烯醇化酶的影响[J]. 陕西中医，2021,42(5):586-589.
[36]曹勇，郑慧军，刘彪，等. 醒神活血通腑方治疗急性大面积脑梗死术后昏迷疗效及对VCAM-1、IL-10、TNF-α水平的影响[J]. 现代中西医结合杂志，2021,30(13):1394-1397,1402.
[37]王丹，武继涛，赵铎. 通腑通络开窍汤治疗急性脑梗死[J]. 中医学报，2020,35(2):388-392.
[38]李娜，于海芙，朱菊花. 醒神通腑方联合胞二磷胆碱对急性脑梗死昏迷患者神经功能损伤的影响[J]. 西部中医药，2020,33(12):84-88.
[39]方名胜，孙愔叡，李迎亚. 自拟祛痰通腑化瘀方对脑梗死恢复期(痰热瘀结证)患者血液流变学及血清UCH-L1、NSE、VEGF水平的影响[J]. 武警医学，2019,30(7):580-583.
[40]谢琛，刘静茹. 自拟通腑化痰活血汤结合西医常规疗法治疗急性脑梗死[J]. 国际中医中药杂志，2019,41(4):335-338.
[41]陈沛，江澜，韩笑，等. 星蒌承气汤治疗急性缺血性中风病痰热腑实证的临床观察[J]. 中华中医药杂志，2018,33(10):4764-4767.
[42]尹书会，刘爽，牛焕敏，等. 星蒌承气汤治疗缺血性中风病急性期痰热腑实证的临床疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2018,16(11):1487-1489.
[43]黄志平，张俊锋，洪枫，等. 醒神通腑方联合胞二磷胆碱注射液治疗急性脑梗死昏迷疗效及对VCAM-1、IL-10、TNF-α的影响[J]. 中国中医急症，2017,26(6):1055-1057.
[44]徐月华，徐建华. 自拟通腑祛痰方联合依达拉奉治疗急性缺血性中风的临床观察[J]. 中国中医急症，2017,26(2):300-302.
[45]邸杰，崔春霞，刘钟，等. 化痰通腑泻热方加减辨治缺血性中风急性期的临床研究[J]. 中国中医急症，2015,24(4):715-717.
[46]刘强. 通腑开窍汤治疗脑梗死急性期昏迷的临床观察[J]. 中国中医急症，2015,24(10):1859-1861.
[47]李京，朱宏勋，曹锐. 化痰通腑汤治疗急性脑梗死78例临床观察[J]. 中国中西医结合急救杂志，2014,21(3):180-182.

[48]李艳景，卢先彬，游俊梅．通腑泄热汤治疗脑梗死的临床观察[J]．中国中医急症，2014,23(4):768-769.
[49]朱宏勋，胡文忠，曹锐．化痰通腑法对急性缺血性中风病患者炎性因子的影响[J]．北京中医药，2012,31(11):808-810.
[50]王新志，代景娜．通腑法治疗急性缺血性中风40例临床观察[J]．国际中医中药杂志，2011,33(6):541-543.
[51]唐祎周，许文婷，关莹，等．“培元通腑法”针药结合治疗痰热腑实型卒中的疗效观察及对脑肠肽、肠道菌群的影响[J]．中华中医药学刊，2023,41(2):144-148.
[52]陶盟，万钢．通腑化痰方内服外擦联合刺络拔罐治疗缺血性中风肢体功能障碍疗效观察[J]．现代中西医结合杂志，2016,25(18):2014-2016.
[53]赵西岳，仝瑞龙．通腑化痰汤治疗缺血性脑卒中痰热腑实证30例[J]．长春中医药大学学报，2010,26(3):377-378.
[54]李锋华．自拟通腑涤痰方联合微创血肿清除术治疗基底节区脑出血临床观察[J]．中国中医急症，2016,25(11):2189-2191.
[55]洪素妹，孙淑岩，贾小平，等．高压氧联合通腑醒脑方治疗急性高血压脑出血94例临床观察[J]．河北中医，2015,37(9):1358-1359.
[56]刘健，龚鹏珠，何金奎，等．通腑泄浊方联合小骨窗微创手术治疗急性脑出血的临床观察[J]．中国中医急症，2015,24(4):699-701.
[57]张江，连丽英，史志勇．通腑逐瘀汤治疗高血压脑出血临床观察[J]．四川中医，2013,31(12):92-93.
[58]纪文健，敖小青，吴钢群．祛风通腑法促进高血压脑出血微创术后恢复31例临床研究[J]．江苏中医药，2012,44(11):18-19.
[59]程一升，倪渝鲲，赵元垛．自拟通腑灌肠汤保留灌肠治疗脑出血急性期的疗效观察[J]．中国中医急症，2012,21(11):1735-1737.
[60]陆彦春，叶尚聪，段进成．承气汤联合天麻钩藤饮治疗高血压脑出血40例[J]．陕西中医，2011,32(6):686-687.
[61]潘明辉．中西医结合治疗高血压脑出血临床观察与护理[J]．辽宁中医药大学学报，2010,12(6):218-220.
[62]张建波．中药配合西医分期治疗脑基底节出血临床观察[J]．中医学报，2010,25(4):719-720.
[63]赵君颖，徐里，刘志华．凉血通腑汤灌肠治疗中小量急性脑出血疗效观察[J]．中草药，2009,40(9):1446-1447.
[64]常学辉，张良芝．中西医结合治疗脑出血急性期30例临床观察[J]．北京中医药大学学报(中医临床版)，2009,16(5):20-21.
[65]董瑞杰，邓德明，王志，等．中西医结合治疗高血压脑出血临床观察[J]．中国中医急症，2007,16(8):918-919.
[66]朱文宗，周龙寿，胡万华，等．活血通腑法对高血压脑出血患者血肿微创清除术后血浆内皮素水平影响的研究[J]．中国中西医结合急救杂志，2006,13(6):338-341.
[67]杨俊阁，刘恩松．中西医结合治疗脑出血疗效观察[J]．四川中医，2006,24(10):56-57.
[68]王立新，刘茂才，陆兵勋，等．通腑醒神液直肠滴注对急性脑出血意识状态的影响[J]．中国中医急症，2004,13(2):72-73,64.
[69]赵敏，王新志．通腑化痰法对急性出血性中风血肿吸收速度与神经功能的影响[J]．中医药学刊，2002,20(4):429-430,435.
[70]李斌，符星，钟丽瑶，等．颅内压监测和化痰通腑醒脑法治疗高血压脑出血的临床疗效[J]．实用医学杂志，2016,32(22):3785-3787.
[71]杨风菊，刘远杰．中药通腑开窍液灌肠在高血压性脑出血治疗中的应用[J]．中国中医急症，2015,24(4):608-610,621.
[72]张勇，高觉民，汤忠华..“通腑泄浊方”促进脑出血术后恢复的临床研究[J]．江苏中医药，2012,44(12):31-32.
[73]朱付良，杨晓恒，杨志立．活血通腑清热化痰法治疗急性脑出血128例疗效观察[J]．中国中医急症，2010,19(2):194,196.
[74]王雷芳．开窍通腑法治疗脑出血急性期并中枢性高热临床观察[J]．中国中医急症，2010,19(9):1480-1481.
[75]孟嫣，杨英．中西医结合治疗脑出血急性期29例临床观察[J]．中国中医急症，2009,18(3):349,378.
[76]曹洪涛，崔应麟．逐瘀化痰通腑汤灌肠治疗急性脑出血疗效观察[J]．四川中医，2008,26(10):72-73.
[77]杨劲松，罗治华，陈文娟，等．中药配合超早期颅内血肿清除术治疗脑出血26例[J]．中西医结合心脑血管病杂志，2004,2(7):392.
[78]刘茂才，黄燕，杜宝新，等．中西医结合综合救治高血压性中、大量脑出血201例临床研究[J]．广州中医药大学学报，2001,18(1):13-18.
[79]罗贤亮，杨迎飞，杨成章，等．消瘀通腑汤配合穴位针刺治疗老年脑出血急性期(痰热腑实证)的脑保护作用及对血清Tf、Ft的影响[J]．四川中医，2022,40(4):134-137.
[80]王国强，杨广华，李鹏宇．清热通腑中药治疗急性脑出血伴中枢性高热的疗效及对炎性细胞因子水平的影响[J]．中西医结合心脑血管病杂志，2021,19(22):

3969-3971.
[81]金建哲. 通腑醒神汤联合白虎汤加味治疗高血压脑出血疗效及对炎症因子水平影响[J]. 四川中医, 2021, 39(3):142-144.
[82]陈丽, 李明军. 通腑开窍涤痰汤辅助神经保护类西药治疗高血压性脑出血微创术后的临床疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2020,18(16):2722-2725.
[83]罗巧莹,郭彦,邓丽玲,等. 通腑醒神法治疗脑出血后遗症便秘的疗效观察[J]. 世界中西医结合杂志, 2020,15(5):951-953,957.
[84]李东峰,周国平,周文科,等. 通腑醒神汤辅助神经内镜治疗高血压脑出血改善认知功能和凝血功能的价值[J]. 中华中医药学刊, 2020,38(3):53-56.
[85]龙宇波. 通腑醒神汤联合吡拉西坦注射液对脑出血病人神经功能及血清hs-CRP、NSE、IL-6的影响[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2018,16(7):849-852.
[86]马建波. 白虎汤加味联合通腑合剂治疗脑出血急性期合并中枢性高热疗效及对机体细胞因子水平影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2017,26(22):2475-2477.
[87]费毅,梁元,王鹏程,等. 通腑醒神汤治疗高血压脑出血微创术后病人神经损伤的临床研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2017,15(13):1555-1558.
[88]陈国华,王月古,邱昕,等. 通腑合剂联合甘露醇治疗脑出血脑水肿的临床观察[J]. 内科急危重症杂志, 2011,17(1):28-29,46.
[89]杨红琴,李永清,郝伟,等. 平肝通腑化痰开窍方治疗脑出血45例[J]. 陕西中医, 2008,29(2):164-165.
[90]韩叶萍,艾进伟. 中药灌肠对脑出血发热的影响[J]. 中医学报, 2020,35(6):1329-1332.
[91]张遐智,刘学武,张芳兰. 单用依达拉奉与联用通腑醒神汤对急性脑出血术后血清因子和神经功能影响的对比研究[J]. 中国药物警戒, 2017,14(2):78-81.
[92]程华. 小骨窗微创手术联合中西医药物治疗脑出血患者的临床疗效观察[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2014,22(6):48-49.
[93]丛大伟,张雪峰. 通腑泄浊方治疗老年重症脑出血疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2017,26(7):770-772.
[94]陈家俊,胡浩宇,刘新黎,等. 生大黄粉预防急性脑梗死鼻饲患者吸入性肺炎疗效观察[J]. 浙江中西医结合杂志, 2020,30(7):581-584.
[95]江颖,王凯华,方兴,等. 清肺化痰通腑方预防痰蒙清窍证脑卒中急性期肺部感染临床研究[J]. 中医临床研究, 2017,9(2):21-23.
[96]王新志,王双利. 通腑疗法预防脑卒中相关性肺炎的临床研究[J]. 中医学报,2010,25(4):630-632.
[97]蔡佳吟,陈亨平. 理气通腑法在卒中相关性肺炎高危患者中的预防应用[J]. 中国中医药科技, 2018,25(5):720-722.
[98]张溪,张伟,孙燕,等. 岭南甄氏益气清热通腑法联合针刺治疗卒中相关性肺炎的临床疗效[J]. 实用医学杂志, 2019,35(5):818-821.
[99]陈可为,白慧梅,郭家奎,等. 通腑泻浊方灌肠预防甘露醇肾损害22例临床观察[J]. 北京中医药大学学报, 2012,35(12):855-857,861.

(收稿日期：2024-07-29；修回日期：2025-03-01)
[编辑：焦　爽]

附件 《通腑法治疗中风病临床应用专家共识》制订主要流程和方法

1 提案、申请、立项

《通腑法治疗中风病临床应用专家共识》（以下简称本共识）于2021年7月10日提交立项申请，于2021年12月30日正式发布立项公告（项目编号：20211213-GS-CACM）。

2 成立共识起草组

2.1 共识起草组成立方式

根据工作内容，由共识负责人召集中西医神经内科/脑病专业、呼吸/肺病专业、消化/脾胃专业、循证医学专业、药学专业等专家，采用召开会议、面对面沟通和电话联系等相结合的方式共同成立共识起草组。

2.2 共识起草组组成情况

起草组专家共30名，29名为高级职称，研究领域包括脑病、呼吸、消化、中药学和方法学。其中临床专家来自全国16个城市20家三级甲等医院。

2.3 利益冲突声明

起草组成员与本共识无潜在的利益冲突（包括商业的、专业的或其他方面的利益，以及所有可能被本部共识成果影响的利益），且已签署利益冲突声明书[1]。

3 构建共识问题

3.1 专家访谈

专家访谈方案是由共识负责人和共识工作组成员参考既往共识工作方案，结合相关标准和规范要求[2-3]，经讨论后最终决定的。

3.2 临床调研

3.2.1 调研方案确定的过程及方法 调研方案：采用线上问卷调研的方式，问卷包含专家基本信息和临床问题，临床问题包含基础问题和受试者（P）、干预措施（I）、对照方法（C）、结局指标（O），简称PICOs问题[4]。2022年9月29日至2022年10月13日采用德尔菲法对全国各省市各级医院专家进行调研。

3.2.2 调研对象分布情况 共收回45份问卷。45名专家平均年龄54岁，38名工作年限超过25年；执业范围中医35名、西医1名、中西医结合8名，全部为高级职称，其中44名为主任医师。来自26个省份及31个不同城市的44家三甲医院。

3.3 共识问题清单

包括基础问题和临床问题两部分，基础问题为不能按照PICOs原则构建的问题[5]，临床问题为基于PICOs原则构建的问题[6]。

4 证据的检索、筛选、提取与综合

4.1 证据检索

4.1.1 检索方法 检索中国知网、维普网、万方数据知识服务平台、Sinomed、web of science、PubMed数据库自建库至2022年12月31日数据。文献类型包括随机对照试验（RCT）、队列研究、回顾性研究等临床研究，院士、国医大师、全国名中医、岐黄学者的相关经验、论述等文献，以及相关诊疗标准[7]。文献语言类型为中文和英文。

4.1.2 检索结果 共检索到15 362篇期刊文献，其中中国知网3644篇，维普网2390篇，万方数据知识服务平台4725篇，Sinomed 4494篇，web of science 33篇，PubMed 76篇。

4.2 证据筛选

证据筛选根据Cochrane协作组的标准流程进行[8]。

文献纳入标准：1）关于通腹法的RCT文献；2）院士、国医大师、全国名中医、岐黄学者与通腑法相关的文献；3）3年内的通腑法相关Meta分析文献。

文献排除标准：1）重复发表仅取信息最全面的1篇；2）资料不全或无法获取全文的文献；3）动物实验、细胞实验等基础研究文献。

4.3 证据综合

基础问题参考名家经验和RCT文献相关内容进行总结。临床问题运用Cochrane协作组提供的标准流程[9-10]，从随机序列产生、分配隐藏、对实施者和研究对象施盲、研究结果盲法分析、结果数据完整性、选择性报告及其他偏倚7个方面进行文献质量评价。最后对纳入研究做出“高风险”“不清楚”“低风险”的判定。评价过程由2名研究者独立进行，意见不一致时由第3名研究者协助判定。RCT文献提取数据后，采用Revman 5.4软件进行Meta分析，二分类变量采用相对危险度（*RR*）表示，连续性变量采用均数差（*MD*）表示，均以95%可信区间（95%*CI*）表示效应量。异质性检验

表1　GRADE证据质量分级表

质量等级	定义
高（A）	非常确信观察值接近真实值，进一步研究不大可能改变该观察值的可信度。
中（B）	对观察值有中等强度信息：真实值有可能接近观察值，但仍存在两者不同的可能性，进一步研究可能改变观察值的可信度，且可能改变该观察值的结果。
低（C）	对观察值的确信程度有限：真实值可能与观察值差别很大，进一步研究极有可能改变观察值的可信度，且很可能改变该观察值的结果。
极低（D）	对观察值几乎没有信息：真实值很可能与观察值不同，真实值可能与观察值有很大差别，观察值的结果很不确定。

采用I^2值表示，当$I^2 \geqslant 50\%$时采用随机效应模型。对纳入文献数＞10的观察指标，用漏斗图评估发表偏倚。

5　证据分级

5.1　证据分级方法

运用GRADE系统推荐分级方法[11]，从偏倚风险（局限性）、不一致性、间接性、不精确性、发表偏倚5个方面，对结局指标进行证据分级，分为高级证据（A）、中级证据（B）、低级证据（C）、极低级证据（D）4个等级。详见表1。

5.2　证据概要表

形成证据概要表，整理成电子问卷，准备召开会议形成推荐意见和共识建议。

6　推荐意见和共识建议

本共识主要采用名义组法形成推荐意见和共识建议[12]。会议专家共42名，包括全部起草组专家及项目组工作人员。基础问题超过参会专家70%以上同意，即为确定的共识问题，50%~70%同意为待定，待定问题经专家讨论后决定是否纳入共识意见。临床问题采用GRADE网格计票规则[11]：除了“不确定（或利弊相当）”格以外的任何一格票数超过50%，则达成共识，并直接确定推荐方向和强度；若“不确定（或利弊相当）”格某一侧两格总票数超过70%，则达成共识为弱推荐（可能利大于弊）；其余情况视为未达成共识，进入下一轮投票，投票不超过3轮。

7　撰写共识草案

工作组基于推荐意见结果和专家意见，对相应内容进行补充完善和修改。

8　共识草案的质量评价及适用性评价

8.1　质量评价

由2名方法学专家对共识进行质量评价，同时以表格形式汇总共识的质量评价结果。

8.2　适用性评价

由起草组中的24名临床专家对共识进行质量评价，同时以表格形式汇总共识的适用性评价结果。

8.3　评价结果分析

综合、分析质量评价和适用性评价，结合实际工作情况和共识目的，修改完善共识草案，形成征求意见稿。

9　征求意见后送审

邀请来自全国17个地区26家三甲医院的30名临床专家（全部为高级职称，且非共识起草组成员），对共识草案进行为期1个月的征求意见，共有27名专家给出88条有效意见。将征求到的意见给出“采纳”“部分采纳”“未采纳”的处理意见，汇总成意见汇总处理表。根据征求到的意见修改共识稿和编制说明，随后按中华中医药学会要求整理相关文件送审。

10　发布与更新

本共识于2024年7月3日由中华中医药学会正式发布（GS/CACM 346-2024）。本共识拟3~5年更新一次，更新内容取决于是否有新的、证据级别高的临床文献出现。

参考文献

[1]陈薇，刘建平．中西医结合临床实践指南制定原则和流程[J]．中国中西医结合杂志，2022，42(12)：1413-1417.

[2]邢年路，周英凤，方园，等．基于社会选择理论的妊娠期糖尿病非药物管理患者指南健康问题清单的构建[J]．护理学杂志，2022，37(16)：26-30.

[3]李慧，陈耀龙，韦当，等．中医(中西医结合)临床实践指南制修订方法：临床问题的构建[J]．中华中医药杂志，2016，31(6)：2202-2205.

[4]张福强，晏利姣，胡紫腾，等．中成药临床实践指南制定方法(四)：证据检索与评价[J]．中医杂志，2024，65(1)：60-65.

[5]YAN XF, NI Q, WEI JP, et al. Evidence-based practice method of integrative Chinese and Western medicine based on literature retrieval through PICO question and complementary and alternative medicine topics[J]. Chin J Integr Med, 2010,16(6):542-548.

[6]黄雪原，黄蓉，董航，等. 基于循证医学证据的《儿科输血指南》构建流程：以新生儿溶血病换血治疗的最佳换血量为例[J]. 中国临床新医学，2022,15(8):694-700.

[7]冯雪，段笑娇，孙静文，等. 以延参健胃胶囊为例探讨中成药临床应用专家共识制定中的文献预检索[J]. 中国中药杂志，2021,46(16):4287-4292.

[8]HIGGINS JP, ALTMAN DG, GØTZSCHE PC, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials[J]. BMJ, 2011, 343: d5928. doi: 10.1136/bmj. d5928.

[9]许雅倩，蔡秋晗，王卉，等. 基于Cochrane风险偏倚评估工具和CONSORT中药复方声明评价中成药治疗儿童急性上呼吸道感染的随机对照试验方法学质量与报告质量[J]. 天津中医药，2020，37(3)：308-312.

[10]CROCKER TF, LAM N, JORDÃO M, et al. Risk-of-bias assessment using Cochrane's revised tool for randomized trials (RoB 2) was useful but challenging and resource-intensive: observations from a systematic review[J]. J Clin Epidemiol, 2023, 161:39-45. doi: 10. 1016/j. jclinepi. 2023. 06. 015.

[11]BALSHEM H, HELFAND M, SCHÜNEMANN HJ, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4):401-406.

[12]李高彪，何斌，梁昌昊，等. 基于德尔菲法的《结直肠癌化疗期中医诊疗指南》临床问题和结局指标的收集与确定[J]. 中国中医基础医学杂志，2022,28(4)：565-570.